جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : اسماء فؤاد ابراهيم ياسين
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** بولاق الدكرور **العنوان :** زنين
رقم البطاقة : 28702102107021 **رقم التليفون :** 01147492926 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 18-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 10-02-1987 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي العلاج المساعد لوقاية العظام للمرضي الذين يتلقوا علاج هرموني حمض الزيلودرونيك [14157] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: اسماء فؤاد ابراهيم ياسين
National ID: 28702102107021

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

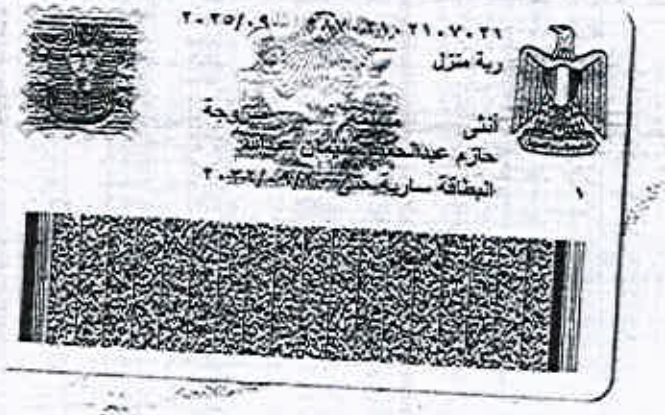
تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Zoledronic acid for bone protection during hormonal therapy**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين


LJ9291380


٢١٠٧٠٢٦
ربة منزل
أنثى
حازم عبدالحميد
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٥/٠٩

Name: اسماء فؤاد ابراهيم	
MR. : 4891	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالتها

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انها

The patient is a 39-year-old premenopausal female with a left breast mass clinically staged as cT3N1. Immunohistochemistry revealed ER 5/8, PR 7/8, HER2 0, Ki-67 10%. She underwent skin-sparing mastectomy with sentinel lymph node dissection, which demonstrated multifocal invasive ductal carcinoma, grade II, with focal osteoclast-like giant cells (5%) and a free retroareolar margin. Pathology reported 0/4 positive nodes and a partial pathological response (pT2N0/4). Post-mastectomy radiation therapy was administered. She received adjuvant chemotherapy consisting of four cycles of doxorubicin/cyclophosphamide (AC) followed by 12 weeks of weekly paclitaxel (Taxol) completed on 21/07/2024, achieving a partial response with respect to axillary lymph nodes. Endocrine therapy was initiated with tamoxifen and zoladex starting 10/2024; the regimen was planned to switch to anastrozole (Arimidex) plus zoladex on 10/2026. A breast-specific mammogram was performed in March 2026, showing free disease; a subsequent ultrasound in April 2026 was scheduled to calculate gonadotropin-releasing hormone (GB) zoladex dosing and continue tamoxifen for an additional three months. The next follow-up visit is planned for 10/10/2026.

تحريرا في ,

التاريخ :	21-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : نهي سعيد علي محمد

يعتمد ,

GUSTAVE ROUSSY

Patient Name		Request No.	13008563
Patient No.	28702102107021	Request Date	08/09/2024
Path No.	13334/24	Verification Date	25/09/2024
Sex	Female	Financial Category	
Age	37Y	Department	Out Patient
Referring Doc		Registered by	manva mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer(post NAOT).
Nature Specimen: Left skin sparing mastectomy specimen and SLNs.

Gross Examination:
- Procedure: Left skin sparing mastectomy specimen measured 17x16x4 cm with no skin covering.
- Tumor extent: 3 ill defined greyish white firm tumor bed site.
- Size: The 1st tumour bed site located (UIQ) and measured 2.2x1.6x1.6 cm, away 1.6 cm from deep margin and 2.6 cm from the skin.
The second tumour bed site located (UIQ) and measured 1x1 cm, away 1.6 cm from deep margin and 2.6 cm from the skin and away 2.6 cm from the 1st tumour bed site.
The third tumour bed site located centrally and measured 0.7x0.7 cm, away 2.6 cm from deep margin and 2.6 cm from the skin.

2- (Frozen, retroareolar area): Fibrofatty tissue piece measured 2.6x2.5 cm, free of gross indurations.

3- SLNs: Fibrofatty tissue piece measured 6x3 cm, enlarging 4 lymph nodes up to 1x1 cm.

Frozen section: Free retroareolar margin and Free SLNs (0/4).

Microscopic Examination:
- Histological type: Multifocal invasive ductal carcinoma.
- (actual tumor size 2.2x2 cm), (collulerity 80%).
- Grade (differentiation, nuclear pleomorphism, mitosis): Grade II (3+2+1)
- Angioinvasion: No.
- Ductal carcinoma in situ: Focal DCIS (6%).
- Free retroareolar margin.
- Lymph node involvement: SLNs (0/4).
- Resection Margins: Free.
- Histologic response to therapy: Partial pathological response.

Verified by:
DR.Menna Nabil

Printing Date: 06/09/2013 15:13:59 Page 1 of 2

Printing By: manva mohamed youss

GUSTAVE ROUSSY

Patient Name	:	Request No.	: 13008563
Patient No.	: 2870210210702	Request Date	: 08/09/2024
Path No.	: 3334/24	Verification Date	: 25/09/2024
Sex	: Female	Financial Category	:
Age	: 37 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc.	:	Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

Diagnosis:
Left breast cancer, Left skin sparing mastectomy specimen and SLNs:
- Multifocal invasive duct carcinoma G II with focal DCIS (5%).
- Free retroareolar margin.
- Free SLNs (0/4).
- Free resection Margins.
- Partial pathological response to therapy.
- Stage: ypT2(m), YpN0.
- RCB: 1.843, RCB class II.

Signature
Dr. Rana Fathy.
Dr. Menna Nabil.

Verified by :
DR.Menna Nabil

Printing Date : 06/09/2025 14:13:59 Page 2 of 2 Printing By : marwa mohamed youss

USTAVE
OUSSY

Patient Name		Request No.	13006563
Patient No.	28702102107021	Request Date	08/09/2024
Path No.	3334/24	Verification Date	26/12/2024
Sex	Female	Financial Category	
Age	37 Y.	Department	Out Patient
Referring Doc.		Registered by	manya mohamed yousso

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

ntermediate) and 3: strong). Total score from 0 to 8.
Scoring system: "Her2"
Reference: ASCO/CAP Her2 Test Guideline Recommendations, 2013.IHC 0: as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells; IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within < 10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is incomplete, intense < 10% of tumor cells.

Signature
Dr.Rana Fathy
Dr.Heba Hassan

Verified by :
Dr.Heba Hassan

Printed by : manya mohamed yousso

Room No. (1) - First Floor - Building No. 937 - Nile Corniche - Nile El Qanater - Cairo, Egypt

Ministry Of Health
Specialized Medical Center
Dar El salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
المركز الطبي المتخصص
مستشفى دار السلام للأورام
إدارة الأشعة

Patient Name: Asmaa Fouad Ibrahim Yasin	Date: 05/06/2024
Exam: MAMMOGRAPHY BOTH	Age: 37 Year(s)
Medical ID: 1263/2024	Pat. ID: 64284

DIGITAL LEFT SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY AND COMPLEMENTARY ULTRASOUND

Indications:

Left breast pathologically proven malignancy on NACTH

Report:

- ACR b: scattered fibroglandular parenchyma
- **Left Breast:**
  - Stable few irregular dense masses are seen in the UIQ with overlying skin thickening (extending over an area of 53 X 41 mm) with internal metallic clip.
  - Ultrasound shows stationary course of the multiple irregular spiculated lesions as follows;
    1. The index lesion at 12 o'clock showing regressive course measuring 17 X 9 mm with currently noted intraductal extension.
    2. Multiple about 4 related similar smaller satellite lesions extending from 12 to 1-2 o'clock.
    3. The furthest one from the index lesion is about 39 mm.
    4. The closest one to the nipple is about 29 mm apart from it.
    5. The closest to the skin is the index lesion itself by about 13 mm.
  - No pathologically enlarged axillary lymph nodes.
  - No supra or infraclavicular lymph node.
- **Right Breast:**

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
الهيئة العامة للمراكز الطبية المتخصصة
مستشفى كورام دار السلام
إدارة الأشعة

Patient Name: Asmaa Hamed Ibrahim Yasin	Date: 05/08/2024
Exam: MAMMOGRAPHY BOTH	Age: 37 Year(s)
Medical ID: 3283/2024	Pat ID: 64284

- No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
- Complementary ultrasound no cystic or solid mass lesions.
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex with average caliber of the retro-areolar central ducts.
- Nonspecific axillary LN.

Outlook:

- Sustained partial therapeutic response of the left breast malignant lesions with overall stationary course as described, (BIRADS 6).
- Normal sonomammography of right breast (BIRADS 1).

Signature Dr. Mohamed Mohson
05/08/2024 3:26 PM

A-Patient ID:
1- Name :

MDT form

3-ID number

Patient Age : 38 Y

Family history

marital status

Comorbidity

BMI

GROUP

Initial STAGE

REASON OF MDT

Date of MDT: 13/10/2024

Clinical data

Breast imaging :

Mass Workup :
pet ct 12/2023
Inf/sl/focal lt breast neoplasm UIQ 2.4 x1.6 cm
SVV 16 UIQ 1.1 x0.8 cm SVV 9.1 ,low grade ipsilateral axillary LN

BX	ER	PR	Her 2 Neu	STAT	KI67
IDC	8/8	7/8	0		10

T	N	M
cT3 ypT2	cN1 ypN0/4	0

Pathomanimography :
12/2023:lt breast UOQ , UIQ multifocal carcinoma 30 x25 mm 11x11 mm BIRADS 5

PATIENT HISTORY :
pt received 4 AC this pet ct 3/2024 : regressing disease/
started taxol weekly x 4 wks last 18/8/2024
coming to cont. neoadj CTH
last MDT:Continue Neoadj. weekly Taxol (for 8 weeks)
pt received 4 AC+ 12 wks taxol last 21/7/2024 with PR regarding ALN
lt skin sparing mastectomy+SLNmultifocal IDC GIT with focal DCIS 5%
free retroareolar margin
LN 0/4
partial pathological response

MDT OUTCOME & PLAN

For PORT
and Adj. zoladex+ tamoxifen (-3y) then AI (for 3y).

MEDICAL ONCOLOGY

SIGNATURE

RADIOLOGY